ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ

120 шаблона „Готово описание“

120 шаблона за описание за рентгенография, КТ, ЯМР и ехография/Doppler. Полетата Техника, Сравнение, Находки и Заключение са готови; Вие попълвате само квадратните скоби. Целта: описание, което Вашият ръководител не трябва да преначисва от начало.

Съдържание

Как се използват шаблоните

Част 1 · Рентгенография — 30 шаблона

Част 2 · КТ — 35 шаблона

Част 3 · ЯМР — 25 шаблона

Част 4 · Ехография и Doppler — 30 шаблона

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как се използват шаблоните

Всеки шаблон е писмената форма на метода в 4 стъпки: ПОДГОТВЕТЕ · ПРЕГЛЕДАЙТЕ · ОПИШЕТЕ · ОБОБЩЕТЕ.

> *Шаблонът не замества мисленето; той Ви помага да запишете мисълта си изчерпателно и в реда, който Вашият ръководител очаква.*

ПОЛЕ НА ШАБЛОНА	СТЪПКА ОТ МЕТОДА	КАКВО ПИШЕТЕ
Техника	ПОДГОТВЕТЕ	Изследване, проекция или секвенции, контраст и фаза, техническа адекватност. Ако е неадекватно, напишете го ясно.
Сравнение	ОПИШЕТЕ · Сравнете	Дата и модалност на предходното изследване; ако няма – «няма предходно изследване за сравнение».
Находки	ПРЕГЛЕДАЙТЕ + ОПИШЕТЕ	Всяка област всеки път в един и същи ред; правилният термин (плътност / сигнал / ехогенност), локализация, размер, контур. Записвайте и важните отрицателни находки.
Заключение	ОБОБЩЕТЕ	Отговор на клиничния въпрос, най-важната находка на първо място, при нужда диференциална диагноза и препоръка. При спешна находка – на кого и в колко часа е съобщена.

Квадратните скоби

В шаблоните [десен/ляв], [.. mm], [гама], [часа] и подобни полета са специфични за пациента. Вариантите са разделени с наклонена черта: оставете подходящия, изтрийте останалите. Преди да подпишете описанието, в текста не трябва да остава нито една квадратна скоба.

1. **Изберете правилния шаблон** — според изследването и основната находка. При нормално изследване започнете с шаблона «Норма».
2. **Попълнете полетата Техника и Сравнение** — ако наистина сте отворили предходното изследване, запишете датата му.
3. **Подредете находките според собствения си оглед** — добавете находката, която липсва в шаблона, изтрийте находката, която не виждате.
4. **Пишете заключението според клиничния въпрос** — можете да използвате подходящото изречение от Банката от 200 изречения за заключение.
5. **Приложете контролния списък за описанието на една страница** — след това подпишете или изпратете на Вашия ръководител.

Капанът „копиране-поставяне“

Грешките в страната, размерите и датите най-често идват от текст, останал от шаблона. Проверявайте всяко изречение от шаблона едно по едно спрямо образа, който виждате; не оставяйте нещо, което не виждате, само защото „го има в шаблона“.

Практиката на Вашето отделение е с предимство

Ако форматът на описанието, класификационните системи и термините във Вашето отделение се различават от тези шаблони, винаги прилагайте формата на отделението. Адаптирайте шаблоните според него.

ЧАСТ 1

Рентгенография (рентгенова снимка)

30 шаблона: 4 нормални, 26 чести находки на дежурство и в рутината.

001 Рентгенография на гръден кош в PA проекция · Норма

НОРМА

Кога се използва: Рентгенографии на гръден кош при възрастни без установена патология при болка в гърдите, кашлица или предоперативна оценка.

Техника: Рентгенография на гръден кош в PA проекция, право. Инспирацията и пенетрацията са адекватни, без изразена ротация.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Трахеята е по средната линия. Размерите на сърцето са в нормални граници. Медиастинумът и хилусните структури са с обичаен вид. В паренхима на двата бели дроба не се установяват консолидация, маса или нодул. Костодиафрагмалните синуси са свободни. Не се наблюдава пневмоторакс. Диафрагмалните куполи са с гладък контур. В наблюдаваните костни структури няма изразена патология.

Заключение: На рентгенографията на гръден кош не се установява остра кардиопулмонална патология.

002 Обзорна рентгенография на корем, право · Норма

НОРМА

Кога се използва: Рентгенографии без патология в отговор на въпроса за обструкция или свободен въздух при коремна болка.

Техника: Обзорна рентгенография на корем, право; диафрагмалните куполи са в образното поле.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Под диафрагмата не се установява свободен въздух. Не се установяват дилатирани чревни бримки с хидроаерични нива. Наблюдава се газ в колона и ректума. Няма изразени рентгеноконтрастни камъни. Сенките на псоаса се различават. Видимите костни структури са без особености.

Заключение: На обзорната рентгенография на корем не се установяват находки в полза на обструкция или свободен въздух.

003 Рентгенография на китка · Норма

НОРМА

Кога се използва: Рентгенографии на китка след падане или навяхване без фрактура или луксация.

Техника: [Вдясно/Вляво] рентгенографии на гривнена става в AP и профилна проекция.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В дистални радиус, улната и карпалните кости не се установява остра фрактурна линия. Радиокарпалната и интеркарпалните ставни междини са запазени, подрежданието е нормално. Няма изразен оток на меките тъкани.

Заключение: [Вдясно/Вляво] не се установява остра костна патология на гривнената става. При клинично съмнение за фрактура на скафоидната кост окултна фрактура не може да се изключи с рентгенография; препоръчва се клинично проследяване и при нужда допълнително изследване.

004 Рентгенография на коляно · Норма

НОРМА

Кога се използва: Случаи с травма или болка в коляното без костна патология.

Техника: [Вдясно/Вляво] рентгенографии на колянна става в AP и профилна проекция.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Не се установява фрактура или луксация. Тибиофеморалната и пателофеморалната ставна междина са запазени. Няма находка в полза на изразен излив в супрапателарната област. Костната минерализация е без особености.

Заключение: [Вдясно/Вляво] На рентгенографията на коляното не се установява остра костна патология.

005 Рентгенография на гръден кош в PA проекция · Пневмоторакс

Кога се използва: Случаи, в които при болка в гърдите, диспнея, травма или след интервенция виждате плевралната линия. Може да изисква съобщаване.

Техника: Рентгенография на гръден кош в PA проекция, право.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] хемиторакс – наличен е пневмоторакс без белодробна съдова рисунка извън плевралната линия; разстояние между плевралната линия и гръдната стена на ниво връх [.. mm]. Изместване на медиастинума [не се наблюдава/към контралатералната страна]. Фрактура на ребро [не се наблюдава/в ... ребро].

Заключение: [Вдясно/Вляво] пневмоторакс. Рентгенологични находки в полза на тензионен [няма/има]. Съобщено на клиничния екип в [часа].

006 Рентгенография на гръден кош · Находки за тензионен пневмоторакс

Кога се използва: Случаи на голям пневмоторакс, придружен от изместване на медиастинума. Тензионният пневмоторакс е клинична диагноза; възможно е да е лекуван, без да се чака рентгенография.

Техника: [PA/AP до леглото] рентгенография на бял дроб.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] хемиторакс – голям пневмоторакс; ипсилатералният бял дроб е колабирал към хилуса. Медиастинумът и трахеята са изместени към контралатералната страна, ипсилатералната хемидиафрагма е сплескана, междуребрията са разширени.

Заключение: [Вдясно/Вляво] рентгенологични находки в полза на голям пневмоторакс и тензионен пневмоторакс. Спешна находка; на клиничния екип [часа] по телефона.

007 Рентгенография на гръден кош в PA проекция · Плеврален излив

Кога се използва: Случаи със затъпяване на костофреничния синус или менискусоподобен образ.

Техника: Право PA [± латерална] рентгенография на бял дроб.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво/Двустранно] – притъпяване на костодиафрагмалния синус и засенчване с менископодобна вдлъбната горна граница; [малко/умерено/много] количество – съвместимо с плеврален излив. Подлежаща консолидация в съседния бял дроб не може да се разграничи. Медиастинум [обичаен/изместен към контралатералната страна].

Заключение: [Вдясно/Вляво/Двустранно] [малко/умерено/много] количество плеврален излив. Подлежаща паренхимна патология не може да се изключи на рентгенографията; препоръчва се корелация с клиниката и при нужда с ехография.

008 Рентгенография на гръден кош в PA проекция · Лобарна консолидация

Кога се използва: Случаи с фебрилитет, кашлица и засенчване с въздушна бронхограма.

Техника: Право PA [± латерална] рентгенография на бял дроб.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [горен/среден/долен] дял – зона на хомогенна консолидация с въздушна бронхограма. Обемът на дяла е запазен. [Не се наблюдава придружаващ плеврален излив/малко количество плеврален излив].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [дял] консолидация; при оценка заедно с клиниката може да съответства на пневмония. Рентгенологичен контрол след лечението се препоръчва според клиничното решение.

009 Рентгенография на гръден кош в PA проекция · Ателектаза

Кога се използва: Случаи, в които виждате засенчване, придружено от находки за обемна загуба.

Техника: Право PA [± латерална] рентгенография на бял дроб.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [дял]: засенчване със загуба на обем; във фисурата [разместване], ипсилатералният хилус е изтеглен [нагоре/надолу] придърпване и повдигане на хемидиафрагмата.

Заключение: [Вдясно/Вляво] [дял] находки, съвместими с ателектаза. За изключване на централна обструктивна причина се препоръчва клинична корелация и при нужда КТ на гръден кош.

010 Рентгенография на гръден кош · Кардиомегалия

Кога се използва: Случаи, в които на PA рентгенографията сърдечната сянка изглежда голяма. На AP рентгенография размерът на сърцето може да е подвеждащ; запишете това в описанието.

Техника: [PA/AP] рентгенография на бял дроб.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Кардиоторакалният индекс е увеличен. Белодробните съдови структури [обичаен/подчертан]. Плеврален излив [не се наблюдава/...].

Заключение: Кардиомегалия [На PA рентгенография]. На рентгенографията не може да се направи разграничение от перикарден излив; при клинична индикация се препоръчва корелация с ехокардиография.

011 Рентгенография на гръден кош · Белодробен оток

Кога се използва: Случаи с диспнея, сърдечна недостатъчност или съмнение за обемно обременяване.

Техника: [PA/AP до леглото] рентгенография на бял дроб.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Двустранни перихилусни засенчвания тип „крила на пеперуда“; засилен интерстициален рисунък (линии на Kerley B), перибронхиално задебеляване и изразени съдове в горните полета. Двустранно [малко количество] плеврален излив. Размери на сърцето [повишен/нормален].

Заключение: Находки в полза на белодробен оток; може да съответстват на кардиогенен оток. Препоръчва се клинична корелация.

012 Рентгенография на гръден кош в PA проекция · Белодробна маса

Кога се използва: Случаи, при които виждате кръгло засенчване с оценими граници.

Техника: Рентгенография на гръден кош в PA и латерална проекция, право.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [горен/среден/долен] зона [.. mm] по размери, [гладък/лобулиран/спикулиран] контур, кръгло засенчване. Калцификация [не се наблюдава]. Хилусно или медиастинално разширение [няма/има]. Плеврален излив [няма/има]. Деструкция на съседните ребра [не се наблюдава].

Заключение: [Вдясно/Вляво] бял дроб [зона]: [.. mm] обемна лезия. За допълнителна оценка се препоръчва КТ на гръден кош с контраст.

013 Рентгенография на гръден кош в PA проекция · Кавитарна лезия

Кога се използва: Случаи, при които виждате лезия със стена, съдържаща въздух.

Техника: Право PA [± латерална] рентгенография на бял дроб.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [горен/среден/долен] зона – кавитарна лезия със стена [тънка/дебела, неправилна] кавитарна лезия; в нея ниво въздух-течност [има/няма]. В околността [консолидация/нодуларни засенчвания].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [зона]: кавитарна лезия. В диференциалната диагноза влизат инфекциозни процеси, включително туберкулоза, белодробен абсцес и кавитираща неоплазма; препоръчва се клинична и микробиологична корелация и КТ на гръден кош.

014 Рентгенография на гръден кош · Фрактура на ребро

Кога се използва: Случаи, в които след гръдна травма виждате прекъсване на кортикалиса.

Техника: Рентгенография на гръден кош в PA проекция [± рентгенография на ребрата].
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [..]. ребро [предно/латерално/задно] в дъгата [недислоцирана/дислоцирана] фрактурна линия. Не се наблюдава пневмоторакс. Плеврална течност в полза на хемоторакс [няма/има]. Подкожен емфизем [няма/има].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [..]. ребро – фрактура; не се установява съпътстващ пневмоторакс. Чувствителността на рентгенографията за фрактури на ребрата е ограничена.

015 Рентгенография на бял дроб до леглото · Позиция на ендотрахеалната тръба

Кога се използва: Пациенти от интензивно отделение и спешна помощ, при които след интубация се иска контрол на позицията на тръбата.

Техника: АР рентгенография на бял дроб до леглото.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Краят на ендотрахеалната тръба, спрямо карината, е на [.. cm] над нея, по средната линия на трахеята. [Върхът на назогастралната сонда е в проекцията на стомаха.] Не се установява пневмоторакс. [Няма новопоявило се засенчване.]

Заключение: Върхът на ендотрахеалната тръба, спрямо карината, е на [.. cm] над [в подходяща позиция]. / Върхът на тръбата [десен главен бронх] – в проекцията; на клиничния екип [часа].

016 Рентгенография на бял дроб до леглото · Централен венозен катетър

Кога се използва: Контрол на позицията на върха и за пневмоторакс след поставяне на ЦВК.

Техника: АР рентгенография на бял дроб до леглото.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [Вътрешна югуларна/подключична] достъп – върхът на поставения централен венозен катетер е в проекцията на [горна празна вена/кавоатриално съустие] – в проекцията. Не се наблюдава пневмоторакс. Няма ново разширение на медиастинума.

Заключение: Върхът на ЦВК [горна празна вена] – в проекцията. Не се наблюдава пневмоторакс, свързан с интервенцията.

017 Рентгенография на гръден кош · Позиция на назогастралната сонда

Кога се използва: Случаи, в които се иска контрол на позицията на върха на назогастралната сонда преди започване на храненето.

Техника: АР рентгенография на гръден кош и горен корем до леглото.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Назогастралната сонда минава по средната линия по хода на хранопровода, преминава диафрагмата, а върхът ѝ се вижда в левия горен квадрант в проекцията на стомаха.

Заключение: Върхът на назогастралната сонда е в проекцията на стомаха. / Върхът на сондата [десен главен бронх/хранопровод] – в проекцията, не е в подходяща позиция; преди употреба на клиничния екип [часа].

018 Рентгенография, право · Пневмоперитонеум

Кога се използва: Случаи, в които при остър корем виждате свободен въздух под диафрагмата. Изисква спешно съобщаване.

Техника: Рентгенография на гръден кош, право / обзорна рентгенография на корем, право.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Двустранно] под куполата на диафрагмата се наблюдава просветляване, съвместимо със свободен въздух.

Заключение: Пневмоперитонеум (свободен въздух). При липса на скорошна операция или интервенция в анамнезата се препоръчва спешна клинична оценка за перфорация на кух орган. Съобщено на клиничния екип в [часа].

019 Обзорна рентгенография на корем, право · Тънкочревна обструкция

Кога се използва: Случаи с повръщане, дистензия и спиране на газове и изпражнения.

Техника: Обзорна рентгенография на корем, право [± в легнало положение].
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Централно разположени дилатирани тънкочревни бримки с видими valvulae conniventes и хидроаерични нива на различна височина. Газ в колона [намален/не се наблюдава]. Няма свободен въздух под диафрагмата.

Заключение: Находки, съвместими с тънкочревна обструкция. За оценка на нивото, причината и усложненията се препоръчва КТ на корем с контраст.

020 Обзорна рентгенография на корем · Съмнение за волвулус на сигмата

Кога се използва: Случаи с изразена дистензия, особено при възрастни пациенти, в които виждате гигантска дебелочревна гънка.

Техника: Право [± в легнало положение] обзорна рентгенография на корем.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Силно дилатирана дебелочревна бримка с форма на обърнато U, със загубени хаустри, простираща се от таза до горния квадрант (образ на „кафеено зърно“).

Заключение: Находки в полза на волвулус на сигмата. Препоръчва се спешна клинична оценка; за потвърждение и оценка на усложненията може да се обсъди КТ. Съобщено на клиничния екип в [часа].

021 Обзорна рентгенография на пикочните пътища · Рентгеноконтрастен камък

Кога се използва: Случаи, при които при болка в хълбока виждате засенчване в областта на бъбрека или по хода на уретера.

Техника: Обзорна рентгенография на пикочните пътища.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] [бъбрек/по хода на уретера/таз] в проекцията на [.. mm] по размери плътно засенчване.

Заключение: [Вдясно/Вляво] [локализация] – засенчване в проекцията, което може да съответства на рентгеноконтрастен конкремент. За разграничаване от флеболит и оценка на обструкцията се препоръчва корелация с ехография или безконтрастна КТ.

022 Рентгенография на китка · Фрактура на дисталния радиус

Кога се използва: Случаи, в които след падане върху ръката виждате фрактурна линия в дисталния радиус.

Техника: [Вдясно/Вляво] рентгенографии на гривнена става в АР и профилна проекция.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] в метафизата на дисталния радиус, към ставната повърхност [разпростираща се/неразпростираща се], [дорзално/воларно] фрактурна линия с ангулация. Фрактура на шиловидния израстък на улната [придружава се/не се придружава]. Скъсяване на радиуса [има/няма].

Заключение: [Вдясно/Вляво] фрактура на дисталния радиус ([вътреставна/извънставна], [дорзално/воларно] с ангулация).

023 Рентгенография на китка · Фрактура на скафоидеума

Кога се използва: Случаи, в които при болезненост в анатомичната табакера виждате фрактурна линия в скафоидеума.

Техника: [Вдясно/Вляво] рентгенографии на гривнена става в АР, профилна и скафоидна проекция.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Скафоидеум [талия/горен полюс/долен полюс] на нивото на [тънък/изместен] фрактурна линия. Мастна линия на скафоида [заличен/запазен].

Заключение: [Вдясно/Вляво] скафоидна кост [талия] фрактура. При фрактури на проксималния полюс се препоръчва ортопедично проследяване поради риск от аваскуларна некроза.

024 Рентгенография на тазобедрена става · Фрактура на шийката на бедрената кост

Кога се използва: Пациенти, особено възрастни, с болка в тазобедрената става и невъзможност за ходене след падане.

Техника: АР на таза и [десен/ляв] профилни рентгенографии на тазобедрена става.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] в шийката на бедрената кост [субкапитална/трансцервикална/базоцервикална] фрактурна линия; [дислоцирана/недислоцирана, импактирана]. Тазобедрената става [съвместим].

Заключение: [Вдясно/Вляво] фрактура на шийката на бедрената кост ([дислоцирана/недислоцирана]). Ако рентгенографията е негативна, а клиничното подозрение е високо, за окултна фрактура се препоръчва ЯМР или КТ.

025 Рентгенография на рамо · Гленохумерална луксация

Кога се използва: Случаи, в които след травма на рамото главицата на хумеруса не е конгруентна с гленоида.

Техника: [Вдясно/Вляво] рентгенографии на рамо в AP и [скапуларна Y/аксиларна] рентгенографии.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] главата на раменната кост спрямо гленоида [предно-долно/задно] част; конгруентността на гленохумералната става е нарушена. Фрактура на големия туберкул [няма/има]. [Hill-Sachs/Bankart] – костни промени в полза на това [не се наблюдава/наблюдава се].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [предно/задно] гленохумерална луксация. Препоръчва се контролна рентгенография след репозицията.

026 Рентгенография на глезенна става · Фрактура на малеол

Кога се използва: Случаи, в които след навяхване видите фрактурна линия в малеолите.

Техника: [Вдясно/Вляво] рентгенографии на глезенна става в AP, mortise и профилна проекция.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [латерален малеол/дистална фибула] на нивото на, спрямо синдесмозата [под/на нивото на/над] [коса/напречна] фрактурна линия. Фрактура на медиалния малеол [има/няма]. Ставната междина на глезенната вилка [симетрично/разширено медиално]. Оток на меките тъкани.

Заключение: [Вдясно/Вляво] [латерален малеол] фрактура; mortise [запазен/разширен].

027 Рентгенография на подбедрица · Фрактура на диафизата на тибията

Кога се използва: Случаи, при които след високоенергийна травма видите фрактура на диафизата на тибията.

Техника: [Вдясно/Вляво] рентгенографии на подбедрица в AP и профилна проекция (с включване на колянна и глезенна става).
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] тибия [проксимален/среден/дистален] трета на диафизата [напречна/коса/спирална/многофрагментна] фрактура; [.. mm] разместване и [предно/задно] ангулация. Фибула [интактен/счупен]. Въздух в меките тъкани [няма/има].

Заключение: [Вдясно/Вляво] фрактура на диафизата на тибията ([тип на фрактурата]); фибула [интактен/счупен]. При наличие на въздух в меките тъкани се препоръчва клинична корелация за открита фрактура.

028 Рентгенография на коляно · Остеоартрит

Кога се използва: Пациенти с хронична болка в коляното без остра травма.

Техника: [Вдясно/Вляво] коляно [в изправено положение] AP и латерална рентгенография.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] в коляното [медиален/латерален] стеснение на тибиофеморалната ставна цепка, маргинални остеофити и субхондрална склероза. Не се наблюдава остра фрактура.

Заключение: [Вдясно/Вляво] в коляното [изразено в медиалния компартимент] дегенеративни промени (остеоартрит). Не се установява остра костна патология.

029 Рентгенография на лакът (деце) · Супракондиларна фрактура на хумеруса

Кога се използва: Случаи, в които при деца с болка в лакътя след падане видите симптом на мастната възглавничка или фрактурна линия.

Техника: [Вдясно/Вляво] рентгенографии на лакътна става в AP и профилна проекция.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: На латералната рентгенография предната мастна възглавничка е повдигната, задната мастна възглавничка се различава. Предната хумерална линия спрямо капитулума [не преминава през средната третина]. В супракондиларната област [тънък/изместен] фрактурна линия [наблюдава се/не се различава ясно].

Заключение: [Вдясно/Вляво] супракондилна фрактура на раменната кост ([дислоцирана/недислоцирана]). Дори фрактурната линия да не се различава, симптомът на задната мастна възглавничка е значим за окултна фрактура; препоръчва се ортопедична консултация.

030 Рентгенография · Погълнато рентгеноконтрастно чуждо тяло

Кога се използва: Пациенти с анамнеза за поглъщане на чуждо тяло, особено деца.

Техника: АР, обхващаща шията, гръдния кош и корема [± латерална] рентгенография.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Горна/средна/дистална част на хранопровода/стомах/тънко черво] в проекцията на [.. mm] по размери рентгеноконтрастно чуждо тяло. Вид на двоен пръстен / двоен контур [има/няма]. Не се установява свободен въздух.

Заключение: [Локализация] – рентгеноконтрастно чуждо тяло в проекцията. Разположение в хранопровода или съмнение за бутонна батерия се приема за спешно; на клиничния екип [часа]. Рентгенонегативните чужди тела може да не се виждат на рентгенографията.

ЧАСТ 2

КТ

35 шаблона: 4 нормални, 31 чести находки на дежурство и в рутината.

031 Безконтрастна КТ на главен мозък · Норма

НОРМА

Кога се използва: Случаи без патология при главоболие, синкоп или лека черепно-мозъчна травма.

Техника: Безконтрастна КТ на главен мозък; аксиалните срезове са оценени в мозъчен и костен прозорец.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Не се наблюдават вътречерепен кръвоизлив, масов ефект или отместване на средната линия. Границата между сиво и бяло вещество е запазена. Вентрикуларната система и браздите са с ширина, съответстваща на възрастта. Базалните цистерни са свободни. Не се наблюдава фрактура на калвариума. Визуализираните околоносни синуси и мастоидни клетки са въздушни.

Заключение: На безконтрастната КТ на главен мозък не се установява остра вътречерепна патология. Ранният исхемичен инсулт може да не се вижда на безконтрастна КТ; при продължаващо клинично съмнение може да се обсъди ЯМР-DWI.

032 КТ на шийни прешлени (травма) · Норма

НОРМА

Кога се използва: Случаи, при които при въпрос за костна увреда на шийния отдел след травма не виждате патология.

Техника: Безконтрастна КТ на шийни прешлени; сагитални и коронарни реконструкции, костен и мекотъканен прозорец.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Подреждането на шийните прешлени е запазено. Не се установява остра фрактура или луксация. Фасетните стави са конгруентни. Краниоцервикалният преход е без особености. Дебелината на превертебралните меки тъкани е нормална.

Заключение: На КТ на шийните прешлени не се установява остра травматична костна патология. Лигаментарна увреда не може да се изключи напълно с КТ; при неврологична находка се препоръчва ЯМР.

033 КТ на гръден кош · Норма

НОРМА

Кога се използва: КТ на гръден кош по рутинни или неонкологични индикации без патология.

Техника: [С интравенозен контраст/Без контраст] КТ на гръден кош; оценена в медиастинален и белодробен прозорец.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В медиастинума не се установяват лимфни възли с патологични размери. Размерите на сърцето са нормални, няма перикарден излив. Главните съдови структури са с нормален калибър. В белодробния паренхим не се установява консолидация, маса или значим нодул. Няма плеврален излив или пневмоторакс. В изобразената горна част на корема и костните структури не се установява патология.

Заключение: На КТ на гръдния кош не се установява значима патология.

034 КТ на корем и таз · Норма

НОРМА

Кога се използва: КТ на корем и таз с контраст без остра патология при коремна болка.

Техника: КТ на корем и таз с венозен контраст, портовенозна фаза. Перорален контраст [е приложен/не е приложен].

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Черният дроб, слезката, панкреасът, надбъбречните жлези и бъбреците са с нормални размери и плътност; не се установяват огнищни лезии. Жлъчният мехур е без особености; интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища не са дилатирани. Не се установява дилатация или задебеляване на стената на чревните бримки. Апендиксът [с нормален вид/не се различава ясно, без белези на възпаление в десния долен квадрант]. Няма свободна течност и свободен въздух. Няма лимфни възли с патологични размери. Пикочният мехур е без особености. Не се установяват литични или бластни лезии в костните структури.

Заключение: На КТ на корем и таз не се установява остра патология.

035 Безконтрастна КТ на главен мозък · Епидурален хематом

Кога се използва: Случаи, в които след черепно-мозъчна травма виждате двойноизпъкнала хиперденсна колекция. Спешно съобщаване.

Техника: Безконтрастна КТ на главен мозък; мозъчен и костен прозорец.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [темпорален/париетален/фронтален] област, неминаваща през шевовете, с биконвексна (лентиформена) форма, в най-дебелото си място [.. mm] – измерена хиперденсна екстрааксиална колекция. В съседния калвариум [линейна фрактурна линия]. Изместване на средната линия [.. mm]. Базалните цистерни [свободен/заличен].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [област] остър епидурален хематом; [.. mm] отместване на средната линия. Спешна находка; на клиничния екип [часа].

036 Безконтрастна КТ на главен мозък · Субдурален хематом

Кога се използва: Случаи, в които виждате полумесечна екстрааксиална колекция, особено при възрастни пациенти и такива на антикоагуланти.

Техника: Безконтрастна КТ на главен мозък.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] по протежение на конвекситета на хемисферата, преминаваща през шевовете, сърповидна, [хиперденсен/изоденсен/хиподенсен/със смесена плътност] субдурална колекция; в най-дебелото си място [.. mm]. Заличаване на браздите, компресия на ипсилатералната странична камера и [.. mm] отместване на средната линия.

Заключение: [Вдясно/Вляво] [остър/подостър/хроничен/остър върху хроничен] субдурален хематом; масов ефект [има/няма]. Съобщено на клиничния екип в [часа].

037 Безконтрастна КТ на главен мозък · Субарахноидален кръвоизлив

Кога се използва: Случаи, в които при внезапно силно главоболие или след травма виждате хипердензитет в цистерните.

Техника: Безконтрастна КТ на главен мозък.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Базалните цистерни/Силвиевите фисури/междухемисферната фисура/кортикалните бразди] – хиперденсен субарахноидален кръвоизлив в тях. Интравентрикуларен кръвоизлив [няма/има]. Разширение на вентрикулите [няма/има]. Паренхимен хематом [няма/има].

Заключение: [Дифузен/Фокален] субарахноидален кръвоизлив. Хидроцефалия [няма/има]. При липса на травма в анамнезата се препоръчва КТ ангиография за аневризма. Съобщено на клиничния екип в [часа].

038 Безконтрастна КТ на главен мозък · Интрацеребрален кръвоизлив

Кога се използва: Случаи, в които при пациент с остър неврологичен дефицит виждате хиперденсен интрапаренхимен хематом.

Техника: Безконтрастна КТ на главен мозък.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [базални ганглии/таламус/лобарен/малкомозъчен] разположени, [.. x .. mm] по размери хиперденсен паренхимен хематом; около него хиподенсен оток. Пробив във вентрикулите [няма/има]. Изместване на средната линия [.. mm].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [локализация] остър интрапаренхимен хематом. За изясняване на подлежащата причина според клиничното състояние се препоръчва допълнително изследване. На клиничния екип [часа].

039 Безконтрастна КТ на главен мозък · Ранни находки за исхемичен инсулт

Кога се използва: КТ, направени по инсултен протокол при остър огнищен неврологичен дефицит.

Техника: Безконтрастна КТ на главен мозък; извършена е допълнителна оценка с инсултен прозорец.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [В басейна на MCA/в инсуларния кортекс/в лентиформното ядро] заличаване на границата между сиво и бяло вещество и лека хиподенсност; заличаване на съседните бразди. Не се наблюдава вътречерепен кръвоизлив.

Заключение: [Вдясно/Вляво] [MCA] басейн – находки, съвместими с ранна остра исхемия; няма вътречерепен кръвоизлив. В рамките на протокола за инсулт на клиничния екип [часа].

040 Безконтрастна КТ на главен мозък · Симптом на хиперденсна МСА

Кога се използва: Случаи, при които при съмнение за инсулт виждате изразена хиперденсност на МСА спрямо контралатералната страна.

Техника: Безконтрастна КТ на главен мозък.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] МСА [М1/М2] сегмент – изразена хиперденсност спрямо контралатералната страна (симптом на хиперденсната артерия). Придружаваща ранна исхемична промяна [няма/има]. Не се установява кървене.

Заключение: [Вдясно/Вляво] Симптом на хиперденсна артерия в МСА; може да е в полза на остър тромб. Препоръчва се оценка с КТ ангиография. Съобщено на клиничния екип в [часа].

041 Безконтрастна КТ на главен мозък · Хидроцефалия

Кога се използва: Случаи, при които вентрикулите са разширени непропорционално на бразди.

Техника: Безконтрастна КТ на главен мозък.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В страничните и третата камера [и в четвъртия вентрикул] изразено разширение, непропорционално на браздите. Перивентрикуларна хиподенсност [има/няма]. Ниво на обструкцията: [ниво/не се различава ясно].

Заключение: [Обструктивна/Комуникираща] находки в полза на хидроцефалия. Спрямо предходното изследване [увеличение/без промяна]. Ако е възникнало остро, съобщено на клиничния екип в [часа].

042 КТ на главен мозък · Туморна маса и вазогенен оток

Кога се използва: Случаи, в които при главоболие, гърч или огнищен дефицит виждате лезия с масов ефект.

Техника: Безконтрастна [± с интравенозен контраст] КТ на главен мозък.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] [дял]: [.. mm] по размери [изодензен/хиперденсен] обемна лезия; около нея вазогенен оток с пръстовидни разклонения. Масов ефект: заличаване на браздите, [компресия на ипсилатералния вентрикул], [.. mm] отместване на средната линия.

Заключение: [Вдясно/Вляво] [дял] обемна лезия и околен вазогенен оток. За характеризиране се препоръчва ЯМР на главен мозък с контраст. Белези на херниация [няма/има; съобщено на клиничния екип].

043 КТ на главен мозък · Фрактура на калвариума

Кога се използва: Случаи, в които при черепно-мозъчна травма виждате фрактурна линия в костния прозорец.

Техника: Безконтрастна КТ на главен мозък; костен прозорец и 3D реконструкция.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] [фронтален/париетален/темпорален/окципитален] кост [линейна/импресионна] фрактурна линия; степен на импресия [.. mm]. Съседно екстрааксиално кървене [няма/има]. Пневмоцефалия [няма/има]. Хематом в окосмената част на главата.

Заключение: [Вдясно/Вляво] [костен] [линейна/импресионна] фрактура. Придружаващ вътречерепен кръвоизлив [не се наблюдава/...].

044 КТ белодробна ангиография · Белодробна емболия

Кога се използва: Случаи, в които на КТ белодробна ангиография при съмнение за БЕ виждате дефект в изпълването. Спешно съобщаване.

Техника: КТ белодробна ангиография. Контрастиране на белодробната артерия [достатъчно/недостатъчно].

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво/Двустранно] [главна/лобарна/сегментна/субсегментна] дефекти в изпълването на белодробните артерии. Съотношение дясна камера/лява камера [повишен/обичаен]; в интервентрикуларния септум [изправяне/изпъкване наляво] [има/няма]. Клиновидна консолидация в периферията [няма/има; може да съответства на инфаркт].

Заключение: [Двустранно] остра белодробна тромбоемболия. Находки в полза на обременяване на дясната камера [има/няма]. Съобщено на клиничния екип в [часа].

045 КТ на гръден кош · Инцидентален белодробен нодул

Кога се използва: Случаи, в които на КТ, направена по друг повод, виждате случаен нодул.

Техника: [С интравенозен контраст/Без контраст] КТ на гръден кош, тънки срезове.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [дял] [сегмент] [.. mm] по размери [солиден/частично солиден/матово стъкло] нодул; [гладък/лобулиран/спикулиран] контур. Калцификация [няма/има].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [дял] [.. mm] [солиден] нодул. Необходимостта от проследяване и интервалът му трябва да се определят съвместно с клиничния екип според рисковия профил на пациента и актуалните препоръки, възприети във Вашето заведение.

046 КТ на гръден кош · Емфизем

Кога се използва: Случаи, в които при пушач или пациент с ХОББ виждате зони на емфизем.

Техника: Безконтрастна КТ на гръден кош; белодробен прозорец.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Двустранно [с преобладаване в горните дялове] [центрилобуларен/парасептален/панлобуларен] зони на емфизем. [Були.] Не се установява консолидация или маса.

Заключение: [Центрилобуларен] емфизем. Не се наблюдава остра паренхимна патология.

047 КТ на гръден кош · Засенчвания тип „матово стъкло“

Кога се използва: Случаи, в които при диспнея, фебрилитет или хипоксемия виждате зони тип „матово стъкло“.

Техника: [Без контраст/С интравенозен контраст] КТ на гръден кош; белодробен прозорец.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Двустранно [периферно/централно/дифузно], [с преобладаване в долните дялове] засенчвания тип матово стъкло. Задебеляване на интерлобуларните септи [придружава се (вид на калдъръм)/не се придружава]. Плеврален излив [няма/има].

Заключение: Двустранни засенчвания тип „матово стъкло“. В диференциалната диагноза са вирусни и атипични инфекции, белодробен оток, алвеоларен кръвоизлив и други възпалителни процеси; препоръчва се клинична и лабораторна корелация.

048 КТ на гръден кош · Пневмоторакс

Кога се използва: Случаи, при които на КТ след травма или интервенция виждате въздух в плевралното пространство.

Техника: КТ на гръден кош; белодробен прозорец.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] хемиторакс [предно/апикално/дифузно] разположен, в най-дебелото си място [.. mm] пневмоторакс. Медиастинално отместване [няма/има]. Пневмомедиастинум [няма/има]. Подкожен емфизем [няма/има]. Фрактури на ребра [няма/има].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [малък/умерен/обширен] пневмоторакс. На клиничния екип [часа].

049 КТ ангиография · Аортна дисекация

Кога се използва: Случаи, в които при внезапна болка в гърдите или гърба виждате интимално ламбо. Спешно съобщаване.

Техника: КТ ангиография – безконтрастна и артериална фаза.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [От възходящата аорта/дистално от лявата подключична артерия] започваща [ниво] – интимален флап; наблюдават се истински и фалшив лумен. Разпространение на дисекацията [към клоновете на дъгата/цьолиакалния ствол/SMA/бъбречните артерии] разпространение: [подробност]. Перикарден излив [няма/има]. Медиастинален хематом [няма/има].

Заключение: [Обхващаща възходящата аорта (Stanford A)/необхващаща възходящата аорта (Stanford B)] дисекация на аортата. Спешна находка; на клиничния екип [часа].

050 КТ на корем · Аневризма на коремната аорта

Кога се използва: Случаи, в които при коремна болка или болка в гърба или случайно виждате разширение на аортата.

Техника: [Контрастна КТ ангиография/КТ на корем в портална венозна фаза].

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В инфрареналната коремна аорта максимален [.. mm] диаметър [фузиформена/сакуларна] аневризмално разширение; калцификати на стената и [мурален тромб]. Разстояние до бъбречните артерии [.. mm]. Периаортен хематом или инфилтрация на мастната тъкан [не се наблюдава/наблюдава се].

Заключение: Инфрареналнa аневризма на коремната аорта, максимален диаметър [.. mm]. Находка в полза на руптура [не се наблюдава/наблюдава се]. При находка за руптура – съобщено като спешна находка на клиничния екип в [часа].

051 КТ на корем · Остър апендицит

Кога се използва: Случаи, в които при болка в десния долен квадрант виждате възпален апендикс.

Техника: КТ на корем и таз с венозен контраст, портовенозна фаза.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Апендикс [.. mm] диаметър, със задебелена стена и повишено контрастно усилване; инфилтрация на околната мастна тъкан. Апендиколит [има/няма]. Периапендикуларна течност, абсцес или свободен въздух [няма/има].

Заключение: Находки, съответстващи на остър апендицит. Находка в полза на перфорация или абсцес [не се наблюдава/наблюдава се]. Съобщено на клиничния екип в [часа].

052 КТ на корем · Остър дивертикулит

Кога се използва: Случаи, в които при болка в левия долен квадрант виждате възпаление в сегмент с дивертикули.

Техника: КТ на корем и таз с венозен контраст.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Сигмоидно/Низходящо] дивертикули в колона; [.. cm] дължина – сегмент със задебеляване на стената и инфилтрация (размазване) на периколичната мастна тъкан. Периколичен свободен въздух [няма/има]. Абсцес [няма/има, .. mm].

Заключение: [Сигмоидно] колон – остър [неусложнен/усложнен] дивертикулит. Оценката на колона след острия период се оставя на клинично решение.

053 КТ на корем · Тънкочревна обструкция

Кога се използва: Случаи със съмнение за обструкция на рентгенографията или с повръщане и дистензия.

Техника: КТ на корем и таз с венозен контраст.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Дилатирани тънкочревни бримки и дистално от тях колабирали бримки; преходна зона [десен долен квадрант/таз/...]. Вероятна причина: [сраствания/херния/маса/не се различава ясно]. Понижено контрастно усилване на чревната стена, мезентериален оток и свободна течност [няма/има]. Пневматоза [няма/има].

Заключение: [Област]: механична тънкочревна обструкция с преходна зона; възможна причина [причина]. Находка в полза на исхемия [не се наблюдава/наблюдава се]. При находка за исхемия – съобщено като спешна находка на клиничния екип в [часа].

054 КТ на корем · Пневмоперитонеум (перфорация)

Кога се използва: Случаи, в които при остър корем виждате свободен въздух на КТ. Спешно съобщаване.

Техника: КТ на корем и таз с венозен контраст; допълнителна оценка в белодробен прозорец.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Пред черния дроб/перипортално/в мезентериума] свободен въздух. Свободна течност [няма/има]. Вероятно място на перфорацията: [стомах/дуоденум/колон];
[дефект на стената/фокално задебеляване на стената/околно възпаление].

Заключение: Пневмоперитонеум; [Възможна локализация] – в полза на перфорация. Спешна находка; на клиничния екип [часа].

055 Безконтрастна КТ · Уретерен камък

Кога се използва: КТ по протокол за камъни при съмнение за бъбречна колика.

Техника: Безконтрастна КТ на корем и таз (протокол за камъни).

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] уретер [в проксималния/средния/дисталния сегмент/на уретеровезикалното съустие] [.. mm] конкремент. В проксималния уретер и събирателната система [лек/умерен/изразен] дилатация; инфилтрация (размазване) на перинеалната мастна тъкан. В контралатералния бъбрек [няма конкремент/конкремент .. mm].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [дистално] в уретера [.. mm] конкремент и [лек] хидроуретеронефроза.

056 КТ на корем · Остър панкреатит

Кога се използва: Случаи с клинично и лабораторно подозрение за панкреатит, при които се иска оценка на усложненията.

Техника: КТ на корем с венозен контраст, [панкреатична фаза и] портална венозна фаза.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Панкреас [дифузно/фокално] – едематозен; инфилтрация и течност в перипанкреасната мастна тъкан. Неконтрастираща се зона в паренхима [няма/има]. Камъни в жлъчния мехур [има/няма]. Слезковата и порталната вена [проходим/съмнение за тромб].

Заключение: Остър [интерстициален едематозен/некротизиращ] находки за панкреатит. Усложнение: [няма/...].

057 КТ на корем · Множество чернодробни лезии в полза на метастази

Кога се използва: Случаи при онкологично болен или когато за първи път виждате множество лезии в черния дроб.

Техника: КТ на корем с венозен контраст, портовенозна фаза.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В двата лоба на черния дроб, най-голямата в сегмент [..]: [.. mm] по размери, множество хиподенсни лезии с периферно контрастно усилване.

Заключение: Множество лезии в черния дроб, които може да съответстват на метастази. Спрямо предходното изследване [нов/увеличен/стабилен]. Препоръчва се клинична и при необходимост хистопатологична корелация.

058 КТ при травма · Увреда на далака

Кога се използва: Случаи, в които при тъпа коремна травма виждате разкъсване или хематом на слезката. Спешно съобщаване.

Техника: Травма КТ с венозен контраст, артериална и портовенозна фаза.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В слезката [.. mm] дължина – лацерация / субкапсуларен хематом. Периспленично и [мазов] свободна течност (съвместима с хемоперитонеум). Активна екстравазация на контраст [няма/има].

Заключение: Увреда на слезката ([лацерация/хематом]) и хемоперитонеум. Находка в полза на активно кървене [няма/има]. Степенуването се извършва по системата, използвана във Вашето лечебно заведение. Съобщено на клиничния екип в [часа].

059 КТ на корем · Проста чернодробна киста

Кога се използва: Случайни кистозни чернодробни лезии с типичен вид.

Техника: КТ на корем с венозен контраст.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Чернодробен сегмент [..]: [.. mm] по размери, рязко ограничена лезия с течностна плътност, с тънка стена, без контрастно усилване.

Заключение: Чернодробен сегмент [..]: лезия, съответстваща на проста киста.

060 КТ на корем · Остър холецистит

Кога се използва: Случаи, в които при болка в десния горен квадрант виждате на КТ възпаление на жлъчния мехур.

Техника: КТ на корем с венозен контраст.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Жлъчният мехур е разтегнат, със задебелена стена; перихолецистна течност и инфилтрация на мастната тъкан. В лумена [различава се конкремент/не се различава конкремент]. Газ в стената, липса на контрастно усилване или перфорация [няма/има].

Заключение: Находки в полза на остър холецистит. Чувствителността на КТ за жлъчни камъни е ограничена; препоръчва се корелация с ехография.

061 КТ на гръбначен стълб · Остра фрактура на прешлен

Кога се използва: Случаи, при които при болка в гърба или кръста след травма виждате фрактура на прешленното тяло.

Техника: Безконтрастна [торако-лумбален] КТ; сагитални и коронарни реконструкции.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [L1] прешлен, в тялото [компресионна/взривна] фрактура; загуба на предната височина. Задна стена [запазен/стеснение на спиналния канал от ретропулсиран фрагмент]. Задните елементи [интактен/счупен].

Заключение: [L1] прешлен – остра на вид [компресионна/взривна] фрактура; в спиналния канал [има/няма стеснение]. При неврологична симптоматика се препоръчва ЯМР.

062 КТ на параназални синуси · Синузит

Кога се използва: КТ на синуси, направени при оплаквания от хроничен или рецидивиращ синузит.

Техника: Безконтрастна КТ на параназалните синуси; коронарна реконструкция.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво/Двустранно] [максиларен/етмоидален/фронтален/сфеноидален] синус – [задебеляване на лигавицата/ниво въздух-течност/пълно изпълване]. Остиомеаталният комплекс [отворен/затворен]. Не се установява костна деструкция, орбитално или интракраниално разпространение.

Заключение: [Локализация] находки, съвместими със синузит. Нивото въздух-течност може да съответства на остър синузит; препоръчва се клинична корелация.

063 КТ на корем · Инцидентален надбъбречен нодул

Кога се използва: Случаи, в които на КТ, направена по друг повод, виждате случаен нодул в надбъбречната жлеза.

Техника: [Без контраст/С интравенозен контраст] КТ на корем.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] в надбъбречната жлеза [.. mm] по размери, гладко ограничен нодул; [безконтрастна плътност .. HU/на контрастното изследване не може да се характеризира].

Заключение: [Вдясно/Вляво] надбъбречен нодул. Необходимостта от характеризиране и проследяване трябва да се определи съвместно с клиничния екип според актуалните препоръки; при нужда се препоръчва КТ по надбъбречен протокол или ЯМР с химично отместване (chemical shift).

064 КТ на гръден кош · Пневмония (консолидация)

Кога се използва: КТ при пневмонии, неясни на рентгенографията или със съмнение за усложнение.

Техника: [Без контраст/С интравенозен контраст] КТ на гръден кош.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [дял]: консолидация с въздушна бронхограма; около нея засенчвания тип матово стъкло. Плеврален излив [няма/има]. В медиастинума [с реактивен вид] лимфни възли. Кавитация или абсцес [няма/има].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [дял] консолидация; може да съответства на инфекциозен процес (пневмония). Контрол след лечението се препоръчва според клиничното решение.

065 КТ при травма · Хемоперитонеум

Кога се използва: Случаи, в които при тъпа коремна травма виждате свободна течност.

Техника: Травма КТ с венозен контраст.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Морисонов джоб/перисплenално пространство/таз]: свободна течност; плътност [.. HU], съответстваща на хемоперитонеум. Увреда на паренхимните органи [не се наблюдава/...]. В чревната стена и мезентериума [не се наблюдава патология/...].

Заключение: [Малко/Умерено/Много] количество хемоперитонеум. Ако не се наблюдава увреда на паренхимен орган, се препоръчва клинично проследяване за увреда на червата или мезентериума. На клиничния екип [часа].

ЧАСТ 3

ЯМР

25 шаблона: 3 нормални, 22 чести находки в рутината и на дежурство.

066 ЯМР на главен мозък · Норма

НОРМА

Кога се използва: ЯМР на главен мозък без патология при изследване за главоболие, световъртеж или гърч.

Техника: ЯМР на главен мозък; аксиални T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI/T2*], [T1 след контраст] секвенции.
Сравнение: [гама] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: В мозъчния паренхим не се установява сигнална аномалия. Няма рестрикция на дифузията на DWI. Вентрикулната система и браздите съответстват на възрастта. Срединните структури са без особености.
[След контраст не се наблюдава патологично усилване.] В главните артерии се наблюдават flow voids (празноти от кръвотока).
Заключение: На ЯМР на главен мозък не се установява значима патология.

067 Лумбален ЯМР · Норма

НОРМА

Кога се използва: Случаи на болка в кръста без патология на диск, корен или канал.

Техника: Лумбален ЯМР; сагитални T1, T2, STIR и аксиални T2 секвенции.
Сравнение: [гама] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Лумбалната лордоза е запазена, подреждането на прешлените е нормално. Височината на прешленните тела и сигналът на костния мозък са без особености. Не се установява изразена дегенерация или херниация на междупрешленните дискове. Гръбначният канал и невралните форамени са свободни. Conus medullaris е на нормално ниво и с нормален сигнал.
Заключение: На лумбалния ЯМР не се установява значима патология.

068 ЯМР на коляно · Норма

НОРМА

Кога се използва: Случаи с болка или травма на коляното без структурна патология.

Техника: [Вдясно/Вляво] ЯМР на колянна става; PD с потискане на мазнините, T1 и T2 секвенции, в три равнини.
Сравнение: [гама] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: В менискусите не се установява повишен сигнал в полза на разкъсване. Предната и задната кръстна връзка, колатералните връзки и екстензорният апарат са без особености. Няма оток на костния мозък. Ставният хрущял е запазен. Няма изразен ставен излив.
Заключение: [Вдясно/Вляво] На ЯМР на коляното не се установява значима патология.

069 ЯМР на главен мозък · Остър инфаркт (DWI)

Кога се използва: Случаи, в които виждате рестрикция на дифузията при остър огнищен дефицит. Съобщаване.

Техника: ЯМР на главен мозък; секвенции DWI/ADC, FLAIR, T2, SWI/T2*.
Сравнение: [гама] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [област] зона с рестрикция на дифузията, хиперинтензна на DWI и хипоинтензна на ADC картата. На FLAIR [без изразена промяна в сигнала/лека хиперинтензност]. Хеморагична трансформация [не се наблюдава/наблюдава се].
Заключение: [Вдясно/Вляво] [артерия] басейн – остър инфаркт. На клиничния екип [часа].

070 ЯМР на главен мозък · Демиелинизиращи плаки

Кога се използва: Случаи, в които при оптичен неврит, сетивен дефицит или проследяване на МС видите лезии в бялото вещество.

Техника: ЯМР на главен мозък; FLAIR (за предпочитане 3D), T2, T1, DWI, T1 след контраст.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Перивентрикуларно, [юкстакортикален], [инфратенториален] разположени, ориентирани перпендикулярно на корпус калозум овоидни T2/FLAIR хиперинтензни лезии. След контраст [.. в лезията има контрастно усилване/няма контрастно усилване].

Заключение: Лезии в бялото вещество, които може да съответстват на демиелинизиращо заболяване. Нова или контрастно усилваща се лезия спрямо предходното изследване [няма/има]. Диагнозата трябва да се оценява заедно с клиничните данни и актуалните диагностични критерии.

071 ЯМР на главен мозък · Интрааксиална маса с пръстеновидно контрастно усилване

Кога се използва: Контрастно усилващи се паренхимни лезии с масов ефект и оток.

Техника: ЯМР на главен мозък с контраст; DWI, [перфузия], SWI секвенции.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] [дял]: [.. mm] по размери, неправилно пръстеновидно контрастираща се маса с централна некроза; около нея вазогенен оток и масов ефект. Разпространение към корпус калозум [няма/има]. Изразена рестрикция на дифузията в централната част [няма/има].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [дял] пръстеновидно контрастираща се интрааксиална маса; в диференциалната диагноза на първо място се обсъждат глиален тумор с висока степен и метастаза. При изразена централна рестрикция на дифузията в диференциалната диагноза трябва да се включи абсцес.

072 ЯМР на главен мозък · Менингиом

Кога се използва: Екстрааксиални маси с дурална основа и хомогенно контрастно усилване.

Техника: ЯМР на главен мозък с контраст.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Област]: с дурална основа, [.. mm] по размери, изоинтензна на T1, хомогенно контрастираща се екстрааксиална маса; симптом на дуралната опашка. Оток в съседния паренхим [няма/има]. Масов ефект [няма/има].

Заключение: [Област]: екстрааксиална маса, съвместима с менингиом.

073 ЯМР на хипофиза · Аденом на хипофизата

Кога се използва: ЯМР на хипофиза, направени поради хормонално нарушение или отпадане на зрителното поле.

Техника: ЯМР на хипофиза; тънки коронарни и сагитални T1, T2 и динамични серии с контраст.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В хипофизната жлеза [.. mm] по размери лезия с по-късно контрастно усилване от нормалната жлеза в динамичните серии. Супраселарно разпространение [няма/има]; компресия на оптичната хиазма [няма/има]. Инвазия в кавернозния синус [съмнителен/няма]. Хипофизното стъбло [по средната линия/девиирана].

Заключение: Хипофиза [микро/макро] лезия, съвместима с аденом. Препоръчва се ендокринологична корелация.

074 ЯМР на главен мозък · Мозъчен абсцес

Кога се използва: Случаи, в които при фебрилитет и огнищен дефицит видите лезия с гладка стена и пръстеновидно контрастно усилване. Съобщаване.

Техника: ЯМР на главен мозък с контраст; включително DWI/ADC.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Локализация]: [.. mm] по размери, тънко и гладкостенно пръстеновидно контрастираща се лезия; съдържимото ѝ показва изразена рестрикция на дифузията на DWI. Околен вазогенен оток.

Заключение: Находки, съответстващи на мозъчен абсцес. Съобщено на клиничния екип в [часа].

075 ЯМР на главен мозък и ЯМР венография · Тромбоза на венозен синус

Кога се използва: Пациенти с главоболие, гърч или папиледем, особено при наличие на рискови фактори. Съобщаване.

Техника: ЯМР на главен мозък и ЯМР венография с/без контраст.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Горен сагитален/напречен/сигмоиден] синус – загуба на нормалния flow void и сигнал, съвместим с тромб; на ЯМР венографията дефект в изпълването/липса на кръвоток. Венозен инфаркт или хеморагия в съседния паренхим [няма/има].

Заключение: [Синус] тромбоза. На клиничния екип [часа].

076 ЯМР на главен мозък · Хронична болест на малките съдове

Кога се използва: Неспецифични лезии на бялото вещество при възрастни пациенти или пациенти със съдови рискови фактори.

Техника: ЯМР на главен мозък; секвенции FLAIR, T2, DWI.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Двустранно в перивентрикуларното и дълбокото бяло вещество точковидни, на места с тенденция към сливане T2/FLAIR хиперинтензитети. Няма рестрикция на дифузията на DWI. [Хронични лакунарни инфаркти.]

Заключение: Промени в бялото вещество, които може да съответстват на хронична болест на малките съдове. Не се установява остър инфаркт.

077 Лумбален ЯМР · Дискова херния

Кога се използва: Лумбални ЯМР, направени при болка в кръста и крака (радикулопатия).

Техника: Лумбален ЯМР; сагитални T1, T2 и аксиални T2 секвенции.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: L [4-5] в диска загуба на T2 сигнала и намалена височина; [десен/ляв] [парамедианна/форaминална] [протрузия/екструзия] херниация. [Вдясно/Вляво] [L5] нервен корен – [контакт/компресия]. Гръбначният канал [проходим/стеснен]. Невралните форамени [проходим/стеснен].

Заключение: L [4-5] [десен парамедианен] диск [екструзия]; [L5] нервен корен – [компресия].

078 Цервикален ЯМР · Дисково-остеофитен комплекс

Кога се използва: Цервикални ЯМР, направени при болка в шията и ръката или изтръпване.

Техника: Цервикален ЯМР; сагитални T1, T2, STIR и аксиални T2 секвенции.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: C [5-6] на нивото на [десен/ляв] [парамедианна/форaминална] дисково-остеофитен комплекс; [десен/ляв] стеснение на невралния форамен. Сигнал на гръбначния мозък [обичаен/T2 хиперинтензен].

Заключение: C [5-6] дисково-остеофитен комплекс с [десен] форaминално стеснение. Промяна в сигнала на гръбначния мозък [няма/има; може да съответства на миелопатия].

079 Торакален ЯМР · Епидурална компресия и компресия на гръбначния мозък

Кога се използва: Болка в гърба или нов неврологичен дефицит при пациент с известно злокачествено заболяване. Спешно съобщаване.

Техника: Торакален с контраст [и на целия гръбначен стълб] ЯМР.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: T [..] прешлен – T1 хипоинтензна, контрастираща се лезия на костния мозък; стеснение на спиналния канал с епидурално разпространение и компресия на гръбначния мозък. Повишение на T2 сигнала в гръбначния мозък [няма/има]. На останалите нива [няма допълнителни лезии/допълнителни лезии].

Заключение: T [..] на нивото лезия, която може да съответства на епидурално туморно разпространение, и компресия на гръбначния мозък. Спешна находка; на клиничния екип [часа].

080 Лумбален ЯМР · Остра компресионна фрактура

Кога се използва: Случаи, в които при лека травма или болка в кръста без травма виждате загуба на височина на прешленното тяло.

Техника: Лумбален ЯМР; сагитални T1, T2, STIR секвенции.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [L1] загуба на височина на тялото; оток на костния мозък на STIR. Ретропулсия на задната стена [няма/има]. Ангажиране на задните елементи, епидурална или паравертебрална мекотъканна маса [не се наблюдава/наблюдава се].

Заключение: [L1] прешлен [остър/подостър] компресионна фрактура. Находки в полза на патологична фрактура [не се наблюдава/наблюдава се; препоръчва се допълнителна оценка].

081 ЯМР на коляно · Разкъсване на предната кръстна връзка

Кога се използва: Случаи с нестабилност и излив след ротационна травма.

Техника: [Вдясно/Вляво] ЯМР на колянна става; PD секвенции с потискане на мазнините и T1 секвенции, в три равнини.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: В ПКС [проксимален/среден сегмент] прекъсване на целостта и загуба на нормалния линеен вид. Костна контузия в латералния феморален кондил и постеролатералното тибиално плато [има/няма]. Ставен излив.

Заключение: [Пълна дебелина/Частична] руптура на ПКС. Придружаваща [менискус/колатерален лигамент] патология [няма/има].

082 ЯМР на коляно · Разкъсване на менискус

Кога се използва: ЯМР на коляно, направени при блокиране, болка по ставната междина или след травма.

Техника: [Вдясно/Вляво] ЯМР на колянна става; PD секвенции с потискане на мазнините.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Медиален/Латерален] менискус [задно рогче/тяло/предно рогче] част, достигащ до ставната повърхност [хоризонтална/коса/радиална/лонгитудинална] повишение на сигнала.
[Не се наблюдава/Наблюдава се дислоциран фрагмент от менискуса (гръжка на кофа).]

Заключение: [Медиален] менискус [задно рогче] [коса] руптура.

083 ЯМР на коляно · Костна контузия

Кога се използва: Случаи след травма с нормална рентгенография, при които на ЯМР виждате оток на костния мозък.

Техника: [Вдясно/Вляво] ЯМР на колянна става; PD секвенции с потискане на мазнините и T1 секвенции.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Латерален феморален кондил/тибиално плато]: оток на костния мозък в сериите с потискане на мазнините, без ясна фрактурна линия. Линейна хипоинтензна фрактурна линия на T1 [няма/има].

Заключение: [Област]: костна контузия;
[не се наблюдава фрактурна линия/наблюдава се субхондрална фрактурна линия].

084 ЯМР на рамо · Разкъсване на ротаторния маншон

Кога се използва: ЯМР на рамо, направени при болка в рамото и слабост при абдукция.

Техника: [Вдясно/Вляво] ЯМР на раменна става; PD/T2 с потискане на мазнините и T1 секвенции.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: На сухожилието на m. supraspinatus [предно] част [частична дебелина откъм ставната повърхност/откъм бурсата/пълна дебелина] руптура; ретракция [.. mm]. Атрофия или мастна дегенерация на мускула [няма/има]. Течност в субакромиално-субделтоидната бурса.

Заключение: В сухожилието на m. supraspinatus [пълна дебелина/частична дебелина] руптура; ретракция [.. mm].

085 ЯМР на тазобедрена става · Аваскуларна некроза на главицата на бедрената кост

Кога се използва: Пациенти с болка в тазобедрената става, прием на кортикостероиди или други рискови фактори.

Техника: ЯМР на двете тазобедрени стави; коронарни T1, STIR и аксиални секвенции.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] в главата на бедрената кост субхондрално разположена, картоподобна зона, обградена от T1 хипоинтензна линия; на T2 симптом на двойната линия. Колапс на ставната повърхност [няма/има]. Ставен излив [няма/има]. Контралатералната главица на бедрената кост [обичаен/подобна промяна].

Заключение: [Вдясно/Вляво] аваскуларна некроза на главата на бедрената кост; колапс на ставната повърхност [не се наблюдава/наблюдава се].

086 ЯМР на черен дроб · Хемангиом

Кога се използва: Характеризиране на чернодробна лезия, останала неясна на ехография или КТ.

Техника: Динамичен ЯМР на черен дроб с контраст; T2, DWI и артериална, портовенозна и късна фаза.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Чернодробен сегмент [..]; [.. mm], лезия, изразено хиперинтензна на T2, с периферно нодуларно и центрипетално прогресиращо контрастно усилване в динамичните серии.

Заключение: Чернодробен сегмент [..]: лезия, съответстваща на типичен хемангиом.

087 MRCP · Холедохолитиаза

Кога се използва: Оценка на жлъчните пътища при пациент с находки за холестаза или жлъчни камъни.

Техника: MRCP; силно T2-претеглени 2D и 3D секвенции.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В дисталния холедох [.. mm] по размери дефект в изпълването, създаващ сигнален дефицит на T2. Холедох [.. mm] диаметър, в интрахепаталните жлъчни пътища [лек] дилатация. В жлъчния мехур [конкременти].

Заключение: Камък в дисталния холедох (холедохолитиаза) и дилатация на жлъчните пътища. При клинично съмнение за холангит – съобщено на клиничния екип в [часа].

088 Лумбален ЯМР · Спондилодисцит

Кога се използва: ЯМР с контраст, направени при фебрилитет, повишени възпалителни маркери и болка в кръста.

Техника: Лумбален ЯМР с контраст; T1, T2, STIR и T1 с потискане на мазнините след контраст.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: L[..] T2 хиперинтензност и контрастно усилване в диска; ерозия и оток на костния мозък в съседните крайни плочки. [Паравертебрално/епидурално] [флегмон/абсцес] [няма/има].

Заключение: L[..] находки, съвместими със спондилодисцит; епидурален абсцес [няма/има]. При епидурален абсцес съобщено на клиничния екип в [часа].

089 ЯМР на коляно · Подколенна (Бейкерова) киста

Кога се използва: Пациенти с подуване или болка в подколенната област.

Техника: [Вдясно/Вляво] ЯМР на колянна става.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В подколенната ямка, простираща се между сухожилията на медиалната глава на m. gastrocnemius и m. semimembranosus [.. mm] течностна колекция. Околен оток в полза на руптура [няма/има].

Заключение: Подколенна (Бейкерова) киста; находка за руптура [няма/има].

090 ЯМР на таз · Проста аднексиална киста

Кога се използва: Характеризиране на аднексиална кистична лезия, установена на ехография.

Техника: ЯМР на таз с контраст; T1, T1 с потискане на мазнините, T2, DWI.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] в яйчника [.. mm] по размери, тънко и гладкостенна, хомогенно хиперинтензна на T2 кистична лезия без солиден компонент или контрастиращи се септи.

Заключение: [Вдясно/Вляво] лезия в яйчника, съвместима с проста киста. Необходимостта от проследяване трябва да се определи от клиничния екип според възрастта на пациентката и менопаузалния статус.

ЧАСТ 4

Ехография и Doppler

30 шаблона: 5 нормални, 25 чести находки на дежурство и в рутината (включително POCUS и eFAST).

091 Ехография на целия корем · Норма

НОРМА

Кога се използва: Ехографии на корем без патология при коремна болка или рутинен контрол.

Техника: Ехография на целия корем; [на гладно].

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Черният дроб е с нормални размери и ехогенност, без огнищни лезии. Жлъчният мехур е с нормална стена, луменът е анехогенен; не се установяват камъни. Интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища не са дилатирани. Панкреасът [видимите части] с нормален вид. Далакът е с нормални размери. Двата бъбрека са с нормални размери и ехогенност на паренхима; пиелокаликсната система не е дилатирана. Пикочен мехур [изпълнен, с нормална стена]. Не се установява свободна течност в коремната кухина.

Заключение: На ехографията на целия корем не се установява патология.

092 Ехография на пикочна система · Норма

НОРМА

Кога се използва: Случаи, при които при болка в хълбока, инфекция на пикочните пътища или бъбречна дисфункция не виждате патология.

Техника: Ехография на пикочна система.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Двата бъбрека са с нормални размери, позиция и дебелина на паренхима; кортикомедуларната диференциация е запазена. Пиелокаликсната система не е дилатирана. Не се установяват камъни или маси. Пикочният мехур [изпълнен, с нормална стена, с анехогенен лумен].

Заключение: На ехографията на пикочната система не се установява патология.

093 Ехография на щитовидна жлеза · Норма

НОРМА

Кога се използва: Случаи без патология при въпрос за нарушена функция на щитовидната жлеза или палпируемо подуване.

Техника: Ехография на щитовидна жлеза и шия; високочестотен линеен трансдюсер.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Щитовидната жлеза е с нормални размери и хомогенна ехогенност на паренхима. Не се установяват нодули. Васкуларизацията при цветен Doppler е нормална. На шията не се установяват патологично изглеждащи лимфни възли.

Заключение: На ехографията на щитовидната жлеза не се установява патология.

094 Венозен Doppler на долни крайници · Норма

НОРМА

Кога се използва: Венозни Doppler изследвания при съмнение за ДВТ без установена тромбоза.

Техника: [Вдясно/Вляво] венозна Doppler ехография на долен крайник; компресия в сива скала, цветен и спектрален Doppler.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Общата бедрена, бедрената и подколенната вена са напълно компресируеми; в лумена им не се установява тромб. При цветен Doppler луменът е изцяло изпълнен, при спектралното изследване има дихателна вариабилност и отговор на аугментация. [Вените на подбедрицата са включени/не са включени в оценката].

Заключение: [Вдясно/Вляво] долен крайник [в дълбоките вени] не се установява тромбоза.

095 eFAST · Отрицателен

Кога се използва: Случаи, при които на eFAST до леглото при пациент с травма не виждате свободна течност и пневмоторакс.

Техника: eFAST до леглото.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Не се установява свободна течност в джоба на Морисон, спленоренално и в таза. При субксифоидно изобразяване няма перикарден излив. Двустранно се наблюдава плъзгане на белия дроб (lung sliding).

Заключение: На eFAST не се установяват находки в полза на свободна течност, перикарден излив или пневмоторакс. Отрицателният eFAST не изключва органна увреда; според клиничното състояние се препоръчва КТ.

096 Ехография на корем · Холелитиаза

Кога се използва: Случаи, в които в жлъчния мехур виждате ехогенно огнище с акустична сянка.

Техника: Ехография на корем; на гладно.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В лумена на жлъчния мехур, най-големият [.. mm] по размери, ехогенни огнища със задна акустична сянка, подвижни при промяна на позицията. Дебелина на стената [обичаен/повишен]. Перихолецистна течност [няма/има]. Сонографски симптом на Мърфи [отрицателен/положителен]. Холедохът [.. mm].

Заключение: Холелитиаза. Находка в полза на остър холецистит [не се наблюдава/наблюдава се].

097 Ехография на корем · Остър холецистит

Кога се използва: Случаи с болка в десния горен квадрант, фебрилитет и сонографски симптом на Мърфи.

Техника: Ехография на корем.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Жлъчният мехур е разтегнат, със задебелена стена [и едематозна, двоен контур]; в шийния сегмент [.. mm] конкремент. Перихолецистна течност [има]. Сонографският симптом на Мърфи е положителен.

Заключение: Находки, съответстващи на остър калкулозен холецистит. Съобщено на клиничния екип в [часа].

098 Ехография на пикочна система · Хидронефроза

Кога се използва: Случаи, при които при болка в хълбока, бъбречна колика или бъбречна дисфункция виждате дилатация на събирателната система.

Техника: Ехография на пикочна система.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] в бъбрека [лек/умерен/изразен] пиелокаликсна дилатация; проксимален уретер [дилатиран/не се наблюдава]. Дебелина на паренхима [запазен/изтънен]. Като причина за обструкцията [конкремент .. mm на уретеровезикалното съустие/не се наблюдава ясна причина]. Пикочният мехур [..].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [лек/умерен/изразен] хидронефроза; [възможна причина]. Ако причината не е ясна, се препоръчва корелация с безконтрастна КТ.

099 FAST · Свободна течност в джоба на Морисон

Кога се използва: Случаи, при които виждате свободна течност на FAST при пациент с травма. Спешно съобщаване.

Техника: FAST до леглото.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В джоба на Морисон [и в спленоренално пространство/в таза] анехогенна свободна течност. Перикарден излив [няма/има].

Заключение: FAST положителен: [В Морисоновия джоб] свободна течност. Спешна клинична оценка според хемодинамичното състояние; на клиничния екип [часа].

100 Ехография на гръден кош · Плеврален излив

Кога се използва: Съмнение за излив на рентгенографията или определяне на количество и локализация преди торакоцентеза.

Техника: Ехография на гръден кош; [В седнало положение], интеркостално сканиране.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво/Двустранно] в плевралното пространство [анехогенно/с ехогенно съдържимо/със септи] течност; в най-дълбокото си място [.. mm]. Компресионна ателектаза в съседния бял дроб.
[Не се наблюдава плеврална нодуларност.]

Заключение: [Вдясно/Вляво] [анехогенно/с усложнен вид] плеврален излив.
[Маркиран е подходящ прозорец за торакоцентеза.]

101 Белодробна ехография · B-линии

Кога се използва: Случаи, в които при пациент с диспнея виждате B-линии на белодробна ехография до леглото.

Техника: Белодробна ехография до леглото; двустранен преглед по зони.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Двустранно [предно и латерално] области, във всяка зона множество B-линии. Плеврална линия [гладък/неправилен и задебелен]. Плеврален излив [няма/има].

Заключение: Двустранни дифузни B-линии; съответстват на интерстициален синдром. В съчетание с гладка плеврална линия може да са в полза на кардиогенен белодробен оток; препоръчва се клинична и ехокардиографска корелация.

102 Венозен Doppler · Дълбока венозна тромбоза

Кога се използва: Случаи, в които при пациент с оток и болка в крака виждате вена, която не се компресира. Съобщаване.

Техника: [Вдясно/Вляво] венозна Doppler ехография на долен крайник.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Обща феморална/феморална/поплитеална] вена – тромб, който не се компресира, изпълващ лумена [частично/напълно] изпълващ лумена ехогенен тромб; на цветен Doppler [няма кръвоток/частичен кръвоток]. Тромб [проксимална граница: ..].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [феморопоплитеален] сегмент – находки, съвместими с остра дълбока венозна тромбоза. На клиничния екип [часа].

103 Ехография на десен долен квадрант · Остър апендицит

Кога се използва: Случаи, при които при болка в десния долен квадрант при дете, млад пациент или бременна виждате възпален апендикс.

Техника: Ехография на десен долен квадрант; техника на степенувана компресия.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: В десния долен квадрант, некомпресируем, [.. mm] диаметър, тубулна структура със сляп край (апендикс); на цветен Doppler повишена васкуларизация в стената. Повишена ехогенност на околната мастна тъкан. Апендиколит [има/няма]. Периапендикуларна течност [няма/има].

Заключение: Находки, съответстващи на остър апендицит. Съобщено на клиничния екип в [часа]. / Апендиксът не се визуализира; това не изключва апендицит.

104 Ехография на коремна аорта · Аневризма

Кога се използва: Случаи, в които при скрининг, пулсираща маса или болка в корема и гърба виждате разширение на аортата.

Техника: Ехография на коремната аорта; напречни и надлъжни измервания.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: В инфрареналната коремна аорта максимален [.. mm] диаметър – аневризмално разширение; в лумена [мурален тромб]. Периаортна течност [не се наблюдава/наблюдава се].

Заключение: Инфраренална аневризма на коремната аорта, максимален диаметър [.. mm]. При симптоматичен пациент руптура не може да се изключи с ехография; съобщено на клиничния екип в [часа] и се препоръчва КТ ангиография.

105 Ехография на щитовидна жлеза · Нодул на щитовидната жлеза

Кога се използва: Палпираем нодул или случайно открит нодул на щитовидната жлеза.

Техника: Ехография на щитовидна жлеза; линеен трансдюсер, цветен Doppler.

Сравнение: [дата] – датата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Щитовидна жлеза [десен/ляв] дял [горен/среден/долен] част [.. x .. x .. mm] по размери, [солиден/кистичен/смесен], [хипоехогенен/изоехогенен/хиперехогенен], [гладък/неправилен] ограничен нодул. Микрокалцификати [няма/има]. [Няма/Има вертикална ориентация на дългата ос]. Патологични лимфни възли на шията [няма/има].

Заключение: Щитовидна жлеза [десен лоб]: [.. mm] нодул; според рисковата класификация, използвана във Вашето заведение, [категория]. Необходимостта от тънкоиглена аспирационна биопсия и проследяване трябва да се определи според тази класификация.

106 Ехография на черен дроб · Чернодробна стеатоза

Кога се използва: Случаи, в които виждате дифузно повишена ехогенност на чернодробния паренхим.

Техника: Ехография на черен дроб.

Сравнение: [дата] – датата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: Черен дроб [с нормални размери/увеличен]; ехогенността на паренхима е дифузно повишена спрямо кората на бъбрека; стените на порталната вена и диафрагмата [различава се/не се различава]. Не се установява огнищна лезия.

Заключение: [Лек/Умерен/Изразен] вид, съвместим с хепатостеатоза.

107 Ехография на таз · Съмнение за извънматочна бременност

Кога се използва: Случаи с положителен тест за бременност, при които не се вижда маточна бременност. Съобщаване.

Техника: Трансабдоминално [и трансвагинално] ехография на малък таз.

Сравнение: [дата] – датата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В маточната кухина не се наблюдава гестационен сак. [Вдясно/Вляво] в аднексиалната област, отделно от яйчника [.. mm] хетерогенна маса [/в него жълтъчен сак или ембрион]. В Дъгласовото пространство [с ехогенно съдържимо] свободна течност [има/няма].

Заключение: Не се наблюдава вътрематочна бременност; [десен/ляв] аднексиална маса и [свободна течност] заедно с находки в полза на извънматочна бременност. На клиничния екип [часа].

108 Ехокардиографски прозорец / POCUS · Перикарден излив

Кога се използва: Случаи, в които при диспнея, хипотония или травма виждате перикардна течност при субксифоидно изобразяване.

Техника: Субксифоидно до леглото [и парастернално] образно изследване.

Сравнение: [дата] – датата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: В перикардното пространство [циркулярно/локализирано] анехогенна течност; в най-широкото си място [.. mm]. Диастолен колапс на дясното предсърдие/дясната камера [не се наблюдава/наблюдава се].

Заключение: [Малко/Умерено/Много] перикарден излив. Находки в полза на тампонада [няма/има; съобщено като спешна находка]. За подробна оценка се препоръчва ехокардиография.

109 Ехография на пикочна система · Проста бъбречна киста

Кога се използва: Случайни, анехогенни бъбречни лезии.

Техника: Ехография на пикочна система.

Сравнение: [дата] – датата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Вдясно/Вляво] бъбрек [горен/среден/долен] в полюса [.. mm] по размери, тънкостенна, анехогенна киста със задно акустично усилване, без септи или солиден компонент.

Заключение: [Вдясно/Вляво] лезия в бъбрека, съвместима с проста кортикална киста.

110 Ехография на корем · Чернодробен абсцес

Кога се използва: Случаи, в които при фебрилитет и болка в десния горен квадрант виждате усложнена кистозна лезия в черния дроб.

Техника: Ехография на корем; цветен Doppler.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Чернодробен сегмент [..]: [.. mm] по размери, с неправилна стена, вътрешни ехота и [дебрис] – хипоехогенна/комплексна кистична лезия; около нея [хиперемия].

Заключение: Чернодробен сегмент [..]: лезия, която може да съответства на абсцес. Препоръчва се клинична и лабораторна корелация; при необходимост – КТ с контраст. Съобщено на клиничния екип в [часа].

111 Doppler ехография на скротум · Съмнение за торзия на тестиса

Кога се използва: Случаи, в които при внезапна скротална болка виждате намален кръвоток в засегнатия тестис. Спешно съобщаване.

Техника: Ехография на скротум в сива скала и цветен/спектрален Doppler; сравнение с контралатералния тестис.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] тестис [увеличен, хетерогенен]; интратестикуларен кръвоток при цветен Doppler [не се наблюдава/изразено намален спрямо контралатералната страна]. В семенната връв [вид на водовъртеж]. Контралатералният тестис е без особености.

Заключение: [Вдясно/Вляво] находки, съвместими с торзия на тестиса. Спешна находка; на клиничния екип [часа]. Наличието на кръвоток не изключва напълно торзия.

112 Ехография на корем · Асцит

Кога се използва: Оценка на течност при подуване на корема или преди парацентеза.

Техника: Ехография на корем.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: В коремната кухина перихепатално, периспленално и в таза [малко/умерено/много] количество [анехогенно/с ехогенно съдържимо/със септи] свободна течност. Контур на черния дроб [гладък/нодуларен].

Заключение: [Малко/Умерено/Много] количество асцит. [Маркиран е подходящ прозорец за парацентеза.]

113 Ехография на гърда · Проста киста

Кога се използва: Ехографска оценка на палпируема маса или на лезия, установена при мамография.

Техника: Двустранна ехография на гърди; линеен трансдюсер.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] гърда, на позиция [..] часа, на разстояние от зърното [.. cm] разстояние, [.. mm] по размери, овална, гладко ограничена, анехогенна лезия със задно акустично усилване.

Заключение: [Вдясно/Вляво] гърда – лезия, съвместима с проста киста; според класификацията, използвана във Вашето заведение, [категория].

114 Doppler ехография на каротиди · Атеросклеротична плака

Кога се използва: Оценка на каротидите при инсулт, транзиторна исхемична атака или скрининг за съдов риск.

Техника: Двустранна Doppler ехография на каротидните и вертебралните артерии.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] [обща каротидна/булбус/вътрешна каротидна] в артерията [калцифициран/хипоехогенен/хетерогенен] атеросклеротична плака. Пикова систолна скорост на ниво плака [.. cm/s]. Кръвоток във вертебралните артерии [антеградно].

Заключение: [Вдясно/Вляво] [вътрешна каротидна] атеросклеротична плака в артерията; степента на стеноза според Doppler критериите, използвани във Вашето заведение, [степен]. При значима стеноза се препоръчва корелация с КТ или ЯМР ангиография.

115 Ехография на корем · Дилатация на холедоха

Кога се използва: Случаи, в които при повишени холестазни ензими или жълтеница жлъчните пътища са разширени.

Техника: Ехография на корем.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: Холедох [.. mm] диаметър – дилатиран; интрахепатални жлъчни пътища [дилатиран/не е дилатиран]. В дисталния холедох [.. mm конкремент/причината за обструкцията не се различава; дисталният сегмент не се визуализира поради чревни газове]. В жлъчния мехур [има/няма конкремент].

Заключение: Дилатация на холедоха; [възможна причина]. Ако причината не е установена, се препоръчва MRCP.

116 Ехография на пикочна система · Бъбречен камък

Кога се използва: Случаи, при които при болка в хълбока или хематурия виждате огнище в бъбрека с акустична сянка.

Техника: Ехография на пикочна система.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] бъбрек [долен/среден/горен] полюс, в каликса [.. mm] по размери ехогенно огнище с акустична сянка (артефакт на мерцане (twinkling) на цветен Doppler [има]). Пиелокаликсната система [не е дилатиран/дилатиран].

Заключение: [Вдясно/Вляво] в бъбрека [.. mm] конкремент; [без хидронефроза/придружена от хидронефроза].

117 Белодробен POCUS · Находки за пневмоторакс

Кога се използва: Случаи, при които на белодробна ехография до леглото след травма или интервенция не се наблюдава белодробно плъзгане. Спешно съобщаване.

Техника: Белодробна ехография до леглото; предна гръдна стена, M-mode.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] на предната гръдна стена не се наблюдава белодробно плъзгане (lung sliding); няма B-линии. В M-mode [знак на баркода/стратосферата]. Белодробна точка (lung point) [наблюдава се/не се наблюдава].

Заключение: [Вдясно/Вляво] находки в полза на пневмоторакс ([наблюдава се белодробна точка]). Съобщено на клиничния екип в [часа].

118 Ехография на корем (деце) · Инвагинация

Кога се използва: Случаи, в които при малки деца с пристъпна коремна болка и повръщане виждате образ на мишена. Спешно съобщаване.

Техника: Ехография на корем; линеен и конвексен трансдюсер.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Десен горен квадрант/Десен корем]: на напречен срез вид на мишена (target), на надлъжен срез вид на псевдобъбрек; [.. mm] диаметър – чревен сегмент. В него [лимфен възел/водеща точка] [няма/има]. Кръвоток в стената при цветен Doppler [запазен/намален]. Свободна течност в околността [няма/има].

Заключение: [Илеоколна] находки, съвместими с инвагинация. Спешна находка; на клиничния екип [часа].

119 Doppler ехография на скротум · Епидидимоорхит

Кога се използва: Случаи, в които при скротална болка и оток виждате хиперемия на епидидима.

Техника: Ехография на скротум в сива скала и цветен Doppler.
Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.
Находки: [Вдясно/Вляво] епидидим [глава/тяло] част – увеличена и хетерогенна; на цветен Doppler изразено повишена васкуларизация. В тестиса [има/няма хиперемия]. Реактивно хидроцеле [има/няма]. Контралатералните тестис и епидидим са без особености.

Заключение: [Вдясно/Вляво] [епидидимит/епидидимоорхит] – находки, съвместими с това. Тестикуларният кръвоток е запазен.

120 Ехография на меки тъкани · Абсцес

Кога се използва: Търсене на колекция при случаи с подкожен оток, зачервяване и болка.

Техника: Ехография на повърхностни меки тъкани; линеен трансдюсер, цветен Doppler.

Сравнение: [дата] – дата на предходното изследване, с което е сравнено. / Няма предходно изследване за сравнение.

Находки: [Област]: в подкожната мастна тъкан [.. mm] по размери, неправилно ограничена хипоехогенна колекция с вътрешни ехота и съдържимо, което се движи при компресия; около нея повишена васкуларизация и оток (вид на калдъръм).

Заключение: [Област]: колекция, съвместима с абсцес на меките тъкани, и находки за околен целулит.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете Бонус 1 · Банка от 200 изречения за заключение. Най-трудната част от шаблона е полето „Заключение“; с изреченията за нормални, инцидентални и спешни находки от банката завършвайте всяко описание с едно-единствено ясно изречение.

Преди подписване **Бърз бонус · Контролен списък за описанието на една страница** – дръжте го подръка.